

列酮和匹格列酮血糖的有效剂量分别为4~8 ng/d和30~60 ng/d,可单次服用。

5 餐时血糖调节剂

是近年开发出来的一类新药,其起效快,作用时间短,对餐后血糖有较好效果,故称为餐时血糖调节剂。此类药物的作用机制和磺脲类一样均通过抑制 K^+ -ATP起作用。不同之处在于:(1)和 β 细胞结合的部位不同;(2)对 β 细胞引发直接的胞吐无作用^[2]。目前用于临床的有瑞格列奈和那格列奈,口服后迅速吸收,半衰期短,因而起效快而作用时间较短,可于进餐前即服,不进餐不服药,用药较为灵活,控制餐后血糖较理想。餐后晚期

低血糖及夜间低血糖反应明显减少;仅6%以下经肾脏排泄,可用于老年及肾功能减退患者。这类药物临床运用的时间不是很长,还有很多值得研究的地方。

最后,需要强调的是2型糖尿病降糖治疗并非最终目的,须同时重视其他相关的心血管病危险因素。如鼓励戒烟,降压和调脂治疗等,以达到减少糖尿病各种并发症和合并症的目的,提高患者的生活质量和延长寿命。

参考文献:

- [1] 叶任高,陆再英.内科学[M].第五版.北京:人民卫生出版社,2001.798.
- [2] 廖二元,超楚生.内分泌学[M].北京:人民卫生出版社,2001.1434.

收稿日期:2006-02-20

青霉素族衍生物的不良反应及药物相互作用

姜莉鸣

(湖北民族学院医学院,湖北 恩施 445000)

文章编号:1009-5519(2006)13-2069-01

中图分类号:R9

文献标识码:B

为增加对青霉素的 β -内酰胺类药物不良反应的预见性和防范性,有利于临床应用,特结合相关文献资料及临床实践,对其在临床应用中可能出现的不良反应进行讨论。

1 口服青霉素类

1.1 苯氧甲基青霉素(青霉素V):青霉素V是在发酵产物上增加一个苯氧基乙酸衍生成。它的主要特性是对酸稳定性和增强口服吸收率,1次口服剂量空腹健康成人可吸收60%~70%,30~60分钟可达血药峰值^[1]。临床应用于溶血性链球菌引起的扁桃体炎、球菌引起的中耳炎及敏感菌引起的皮肤化脓感染,但不是严重感染的首选治疗药。其不良反应有轻度胃肠道反应,如恶心、呕吐、腹痛腹泻等,偶见口腔炎、荨麻疹、皮疹等,一般不需停药。长期用药,应定期进行肾功能和血常规检查,肾功能不全者、新生儿和婴儿对本品的肾清除延迟。

1.2 巴氨西林:为一种前体药物,无抗菌活性,口服后水解成为活性的氨苄西林被释放到血液中。它作为脂溶性前体药物,穿透组织能力强于氨苄西林,口服吸收完全,主要用于治疗对氨苄西林敏感的革兰阳性和革兰阴性菌引起的感染。不良反应发生率为2%~4%^[2],有胃肠道症状如恶心和皮疹。本品能透过胎盘屏障,能通过母乳,与别嘌呤醇合用时皮疹率升高。因本品体内水解时会生成乙醛,与一部分药物同用可引起双硫仑样反应^[3]。

2 抗假单胞菌青霉素

2.1 替卡西林:为半合成的 α 羧基青霉素,其结构特点是在青霉素主核的 α 位上有一个羧基团,对某些假单胞菌具有活性,对变形杆菌产生的 β 内酰胺酶具有稳定性,其抗菌活性强于羧苄西林,体内分布类似羧苄西林,胆汁浓度较高。肾功能不全者、新生儿,尤其是肝功能不全者,半衰期会延长,严重肾衰者半衰期可长达15小时。与丙磺舒同服可使其血药浓度增高,半衰期延长。不良反应常见为皮疹、药物热等变态反应,也可见低钾血症,可能由于肾排出量增多及细胞内外再分布所致。肾功能不全的病人应用时有可能引起凝血功能障碍,出血表现和凝血时间明显延长,必要时应加强临床观察。

2.2 哌拉西林:属第三代青霉素,抗菌谱广、活性强。哌拉西林是常用的抗假单胞菌类活性最强的青霉素之一。对链球菌、粪肠

球菌和青霉素敏感的金球菌有良好的疗效。哌拉西林可被大部分 β 内酰胺酶快速水解,单独用哌拉西林治疗绿脓杆菌易导致耐药性发生,临床应用时某些病人可导致血栓性静脉炎和腹泻,注射过快可引起胸部不适、咳嗽、口腔异味、眼结膜充血,有白细胞减少症及血小板异常凝聚。用药时间过长可出现凝血异常,哌拉西林能引起较多的内毒素释放^[4]。近年来研究表明,抗生素治疗引起革兰阴性杆菌释放内毒素可能是脓毒症治疗失败的原因之一。囊性纤维化病人使用本品所致不良反应的发生率较高,可能是这类病人易于产生过敏反应,特别表现在发热上。

3 β 内酰胺酶抑制剂

3.1 阿莫西林/克拉维酸钾:克拉维酸系自链霉菌的培养基中分离而得,为一种“自杀性抑制剂”,仅具微弱的抗菌活性,与阿莫西林以固定的比例混合使用,可保护阿莫西林免受破坏而产生协同作用,同时扩大了抗菌谱,适于对氨苄西林及阿莫西林耐药的产酶菌感染的治疗。口服吸收好,生物利用度易受首过效应影响。国内主要用其注射剂。最常见的不良反应是腹泻、恶心、呕吐及皮疹,其腹泻发生率高于单用阿莫西林,阴道念珠菌病和伪膜性肠炎有时可见。偶有可疑性的AST或ALT升高,绿脓杆菌二重感染和阻塞性黄疸。使用本品或青霉素而出现黄疸或肝功能不全的病者,传染性单核细胞增多症、淋巴细胞性白血病人禁用。大量使用时防止出现尿结晶症。正在服用双硫仑的病人不能应用本品,不应同时使用促尿酸排泄的药物。

3.2 哌拉西林/他唑巴坦:他唑巴坦抗菌活性低,能广泛抑制 β 内酰胺酶,与哌拉西林配伍能增强哌拉西林对大部分产酶菌的活性,两者共用有良好的组织分布。最常见的不良反应是腹泻和过敏性皮肤反应,其它可见血小板减少、发热、嗜酸性粒细胞增多、转氨酶升高。长期使用应定期检查造血功能及血清电解质水平,出现严重腹泻应考虑是否有伪膜性肠炎。

参考文献:

- [1] 徐叔云.现代临床实用药理学[M].北京:华夏出版社,1996.973.
- [2] 罗顺德,康永福,周延安.临床药物治疗学[M].武汉:湖北科技出版社,1997.485.
- [3] 史美甫.精编临床用药必备[M].北京:中国科技出版社,2003.05.
- [4] 王睿.常用进口药物手册[M].北京:金盾出版社,2001.2.